

Vital_活域_赛制与评审细则



Alx Origin Summit

Vital

Healthcare 赛制与评审细则

软件驱动的数字健康

一、赛道定位与成功标准

（一）主办方愿景

让 AI 进入普通人的健康信息理解、日常行为支持与数字健康可及性，因为时间以及复杂程度，我们并不替代医生做诊断或开具处方。Vital 关注 Soft Healthcare：用软件、数据与生成式 / Agent 技术，改善真实用户在理解、依从、陪伴与使用门槛上的痛点，并在隐私与专业边界内负责任地创新。成功作品应同时具备：真实痛点、专业融合、可演示闭环、清晰免责与伦理设计、以及后续孵化或公益落地的思考。

（二）赛道范围

纳入范围（Soft Healthcare）

- 健康信息获取与素养：报告解读、用药说明通俗化、宣教内容个性化、多语言 / 方言 / 低识字适配
- 患者体验与导航：预约与流程指引、出院后理解、行政文书辅助（非临床决策）
- 情绪与行为支持：有边界的数字陪伴、习惯养成、慢病自我管理的非临床支持
- 数字可及性：老年、低数字素养、残障友好交互
- 医疗行政效率的软件侧：分诊导航信息整理、文档结构化、知识库问答（不得替代执业行为）

谨慎参与范围

- 需要医疗器械注册或以临床诊断为主要功能的硬医疗方案
- 药物发现、分子设计、化学合成相关项目
- 声称可诊断疾病、开具处方或替代注册医护人员的系统

上述方向若仅作为背景调研出现可以，但主 Demo 必须落在 Soft Healthcare 软件闭环。

主赛道技术门槛（必须同时满足）

- 可运行门槛：必须提供可访问的 Web / App / 对话 Agent 等原型，现场能走完至少一条完整用户路径。纯 PPT、纯策划、只有渲染图视为未完成。
- AI 结合要求：AI 必须实质改变理解、生成、推荐、交互或流程组织；固定文案网站、简单表单、只接一个聊天框而不改变关键任务，不构成显著 AI + Soft Healthcare 能力。
- 用户路径门槛：Demo 须能指出目标用户是谁、从哪一个具体困扰进入、AI 输出后用户下一步做什么。
- 合规可见门槛：面向用户的健康相关输出必须有显著免责声明；涉及情绪支持时必须有基础危机识别与转介设计。
- 数据门槛：只允许合成数据、公开脱敏数据、团队模拟数据；训练与演示均不得使用未脱敏真实患者资料。

负面清单

- 只有 App 壳体、只有策划案、只有 PPT / 原型图、现场无法操作
- 产品名、界面或路演使用「诊断」「治疗」「处方」「治愈」等词汇，或明示替代医护
- 无免责声明的健康解释 / 陪伴产品
- 涉及情绪支持却完全没有危机识别与本地转介设计
- 上传未评估第三方的可识别健康 / 情绪数据，或隐瞒跨境传输
- 演示真实患者病历或未授权个人信息

（三）评审三问

评委打分前先用三问过滤。任一问明显失败，主奖竞争力显著下降。

- 它真的能实际演示吗？——用户能否在现场走完一条完整路径，而不是只看幻灯片。
- AI 是否真正参与？——去掉模型或 Agent 后，产品是否立刻失去关键能力。
- 是否有 Soft Healthcare 场景且应用清晰？——用户与痛点是否具体，是否诚实区分支持与治疗，免责与数据说明是否到位。

二、参赛对象、规模与组队

（一）参赛对象

面向 AI / 全栈、产品与交互、数字健康、公卫与护理、心理咨询相关背景、健康教育与运营背景选手。不要求人人有临床执照。团队不要求人人会写模型，但至少一人能完成部署、联调与现场演示排障；若做情绪支持方向，建议有选手能了解危机转介与语言边界。

（二）报名与录取

- 滚动报名、人工复核：组委会审核背景、方向匹配与合规意识。
- 优先录取：能说清具体用户、承诺使用合成 / 脱敏数据、角色互补、愿意接受合规 briefing 的团队。

（三）组队规则

- 建议每队 3—5 人，最多 6 人。允许个人报名，可由主办方协助匹配。
- 团队尽量覆盖四类角色中的至少三类：AI / 工程、产品 / 设计、健康或用户研究、合规或内容。
- 锁队时刻以总赛程为准。线下冲刺开始后不得换队或空降替赛。
- 每队指定产品 / 演示负责人，以及合规负责人（免责声明、数据说明、危机转介文案）。
- 鼓励技术 + 产品 / 设计 + 健康相关背景的跨学科组合，但不作硬性职业资格要求。

三、参考方向

Vital 采用两个主参考方向 + 一个自由方向，三个方向均进入 Vital 主榜。方向意在引导而非强制命题。可融合，但须声明主方向。

编号	参考方向	一句话核心
A	健康信息赋能与可及性	看懂、用好健康信息，并降低数字工具使用门槛。
B	智能陪伴与行为支持	有温度、有边界的情绪支持与非临床行为改变协助。
C	开放创新	任何符合 Soft Healthcare 定义的真实痛点，自主权交给选手。

（一）A | 健康信息赋能与可及性

核心：普通人面对检查报告、用药说明、宣教材料时常困惑甚至焦虑；老年、低识字、方言用户门槛更高。AI 如何把复杂文本变成通俗、可行动、个性化的解释，并让不同能力的人用得上？

建议做到

- 有明确的信息对象（一类报告、一类说明、一类宣教或一类导航任务），不是「什么病都答」。
- 可运行解读或交互原型，至少一条完整用户流程可现场走通。
- 输出结构建议包含：通俗解释 + 可行动下一步 + 何时应寻求专业协助。
- 不建议在无专业证明下生成诊断结论、用药建议或替代专业意见的表述。

（二）B | 智能陪伴与行为支持

核心：轻度情绪困扰、压力管理、慢病长期依从性差，需要持续、有温度且严格有边界的数字支持。必须明确区分「支持」与「治疗」，并具备基础风险识别能力。

建议做到

- 行为建议关注生活方式、习惯养成、情绪记录、提醒与动机支持等非临床层面。
- 不在无专业人士参与下涉及用药调整或疾病管理决策。
- 凡提供情绪支持对话或记录，必须具备基础危机关键词识别，并转介真实可靠资源。
- 不提供可能加重风险的建议。

（三）C | 开放创新

核心：任何符合 Soft Healthcare 定义的真实痛点均可。给予最大创意空间，不降低门槛。

需要明确

- 目标用户、真实痛点、为何属于 Soft Healthcare、如何符合统一合规规则。
- 不建议出现诊断 / 治疗声称；必须有免责声明与数据说明。

鼓励方向（非强制）

- 医疗行政软件：文书结构化、患者导航、多语言导诊信息（非分诊诊断）
- 企业 / 社区健康管理的隐私友好方案
- 跨 A/B 的融合，例如「可读的出院说明 + 依从提醒」

四、赛程与关键节点

Vital 采用「线上 72 小时 + 线下冲刺 48 小时」：线上协作完成问题定义与主路径，线下集中打磨、联调与路演。具体日历以 Alx Origin Summit 总赛程为准。

阶段	建议窗口	关键动作
开赛与合规 briefing	线上 0 点	公布赛题、规则、数据红线、组队、危机转介资源列表
线上 72H 预研开发	线上 72 小时	用户路径、信息架构、主流程开发、合成数据准备
线下前检查	线下开始前	提交访问链接、演示脚本、合规包草稿、设备需求
线下冲刺 48H	线下第 1 个 24H	体验打磨、护栏联调、失败路径、录屏备份
Final Call	展示日截止前	提交最终包、复测链接、合规声明签字
路演与颁奖	展示窗口	5—8 分钟路演（含问答），合议颁奖

五、环境、数据与开发资源

Vital 以软件原型为主，核心资源是模型 / API、合成数据规范、合规模板与演示工位，而不是医疗器械。

（一）共用资源分配

- CDE / 官方 API 额度、导师时段按预约分配，禁止单队长期独占答疑。
- 线下前检查提交：演示方式（浏览器 / 手机 / Agent）、是否需要投屏、是否有语音 Demo、网络依赖。

- 密钥不写入公开仓库。

（二）故障降级

若官方模型额度或会场网络因非选手原因故障，赛道负责人可批准使用：本地模型、预先录制的连续真实操作视频、备用热点。不得以 PPT 替代可运行成果。Demo 失败时，允许切到文本路径完成同一条用户故事。

六、提交规范

（一）必交材料

- 可运行 Demo / MVP（访问链接或现场安装包；须在截止前可打开）。
- 不超过 3 分钟备份视频，至少一段连续真实操作（非剪辑特效拼接冒充一次运行）。
- 项目说明：问题、目标用户、方案、AI 承重点、技术栈、团队分工。
- 简要的伦理与合规声明。
- 数据来源与隐私处理说明；使用外部 API / 模型须说明数据处理与是否跨境。
- 路演不侧重 PPT，但需要选手对产品有理解，必须能在短时间内快速讲清问题、方案、Demo、合规边界与落地思考。

（二）现场展示

- 以现场可操作演示为主，视频作稳定性备份。
- 必须说明哪些步骤由模型自动生成，哪些经模板 / 规则 / 人工编辑。
- 演示失败可重试一次；评委同时看预交视频。
- 只有 PPT 或点击热区假数据、无真实模型或规则输出，不视为完成。
- 禁止输入真实观众的健康或情绪隐私信息。

七、评审与计分

（一）评审流程

- 完整性与合规审核：检查可运行性、免责声明、数据说明、情绪方向护栏、赛道匹配。
纯 PPT、造假或重大违规直接淘汰。
- 现场 Demo 与路演：独立打分，观察完整路径、AI 承重、体验、边界表达。
- 合议与复核：异常分差、专项奖资格、回避、演示真实性。

（二）Vital 主赛道评分（100 分）

维度	权重	评分要点
合规、安全与伦理	10%	责任控制、数据最小化、风险控制、透明度、免责声明；B 方向护栏可演示。审核阶段可因缺护栏或诊断声称出局。
问题定义与专业相关性	20%	是否针对真实 Soft Healthcare 痛点；用户画像具体；方案逻辑专业；边界意识。
创新性与用户体验	30%	创意亮点、真实可交互、个性化、多模态、包容性设计、路径流畅。
原型完成度与可开发性体现	20%	功能可演示、流程完整、技术实现合理、72H+48H 约束下完成度高。
落地潜力	20%	后续迭代或持续推进空间、路演清晰、产品力、孵化前景存在

（三）计分原则

- 每维度 1—10 分，按权重计 100 分。
- 评委满额时去一个最高分与一个最低分后取均值；回避时按有效评委均值。
- 平局依次比较：创新性与用户体验 → 问题定义与专业相关性 → 原型完成度。仍相同则无回避评委合议。
- 诊断声称、使用未脱敏真实病历、伪造 Demo、贿票，可一票否决。

八、安全、原创与合规

（一）统一强制规则

数据

- 只允许合成数据、公开脱敏数据集、团队自行模拟生成的数据。
- 训练中不得使用未脱敏的真实患者健康记录或任何可识别个人的健康资料。
- 贯彻最少收集：只处理完成可演示功能所必需的数据。
- 模拟健康 / 情绪输入须在界面告知并取得模拟同意。

医疗声称

- 不出现诊断、处方、治疗建议或声称可替代专业医疗人员。
- 所有面向用户的输出须附带清晰、显著免责声明。
- 不得在产品名称、界面或宣传中使用「诊断」「治疗」「处方」等词汇。

透明度与 Human-in-the-loop

- 标明内容由 AI 生成，并提示可能不准确或存在幻觉。
- 鼓励来源引用或不确定性提示。
- 关键或敏感输出应可编辑、可撤回或经模板约束。
- Agentic AI 须限制权限并说明，避免过度自动化。

隐私与安全

- 原型不得将个人资料上传至未经评估的第三方（尤其跨境）。
- 建议本地或可控环境；使用云服务须说明数据流向。
- 提交必须附数据与隐私处理说明。

精神健康与危机

- 凡涉及情绪支持内容，必须具备基础危机关键词识别与转介机制。
- 不得提供可能加重风险的建议。

（二）原创与演示真实性

- 允许开源框架、开源模型与赛前自有组件，须披露来源与 license。
- 禁止把已上线商业产品换皮参赛；复用旧资产须说明本周新增。
- 如实披露预录、人工编辑、模板与模型各自贡献。

（三）严重问题

- 使用未脱敏真实患者或可识别健康数据
- 核心功能为诊断 / 处方 / 替代医护且拒绝修改
- 伪造 Demo、抄袭、贿票、作弊

九、附录：检查清单

（一）团队提交前自查

- 现场能否不依赖 PPT 走完主用户路径？
- AI 去掉后产品力是否明显变弱？
- 是否只有合成 / 公开脱敏 / 模拟数据？
- 免责声明是否在用户能看见的位置？
- 是否避免诊断 / 治疗 / 处方用语？
- 若做情绪或行为支持：危机触发后能否转到本地资源？
- API 数据流向与是否跨境是否写清？
- 5 分钟内能否讲清用户、痛点、闭环与边界？

（二）建议嵌入的免责声明要点

必须在产品界面显著位置展示以下免责声明：本工具仅供健康信息参考与支持，不构成医疗建议，不能取代专业医护人员的诊断或治疗。如有健康疑虑，请咨询注册医生或相关专业人士。AI 生成内容可能不准确。

情绪支持类另须声明：本服务不是心理治疗或危机干预替代方案。如你正在经历紧急危险，请立即联系当地紧急救援或组委会提供的热线资源。

（三）结语

Vital 希望把 AI 用在人真正卡住的地方：看不懂、用不上、难坚持、缺边界的数字健康体验。我们期待有用户温度、有技术承重、有合规意识、并且能在黑客松真正线下跑起来的作品，为后续孵化奠定基础